

पाइलोप्लास्टी एक सर्जरी है जो गुर्दे (kidney) और मूत्रवाहिनी (ureter) के बीच की संकरी जगह — UPJ (ureteropelvic junction) — को ठीक करती है। यह संकुचन पेशाब को रोक देता है, जिससे दर्द, संक्रमण या गुर्दे पर दबाव पड़ता है। पाइलोप्लास्टी में बाधित हिस्से को हटाकर एक चौड़ा, खुला रास्ता बनाया जाता है — 90% से अधिक सफलता दर के साथ यह सबसे टिकाऊ उपाय है।

इस सर्जरी के बारे में

मूत्रवाहिनी के ऊपरी सिरे पर, जहाँ यह गुर्दे की थैली (renal pelvis) से मिलती है, एक संकुचन पेशाब का बहाव धीमा कर देता है। कभी-कभी पास की एक **blood vessel** इस जगह पर दबाव डालती है। इसे **UPJ obstruction** कहते हैं। पाइलोप्लास्टी में आपके सर्जन:

- संकरे हिस्से को हटाते हैं
- स्वस्थ मूत्रवाहिनी को renal pelvis से **चौड़े, कीप-आकार के जोड़** में सिलते हैं
- ठीक होने तक जोड़ को खुला रखने के लिए एक नरम **stent** अंदर छोड़ते हैं

अधिकतर यह **रोबोटिक या laparoscopic** तरीके से छोटे छिद्रों (keyhole) से होती है; कभी-कभी एक खुले चीरे से।

क्या यह सुरक्षित है?

पाइलोप्लास्टी एक सुस्थापित और अत्यंत प्रभावी सर्जरी है, जिसकी दीर्घकालिक सफलता 90% से अधिक है। किसी भी सर्जरी की तरह इसमें कुछ जोखिम हैं — रक्तस्राव, संक्रमण, या अस्थायी पेशाब का रिसाव (आमतौर पर stent और drain से नियंत्रित)। संकुचन के वापस आने की संभावना कम है और इसे दोबारा ठीक किया जा सकता है।

शब्दों को समझें

Kidney (गुर्दा)

वह अंग जो खून को छानकर पेशाब बनाता है।

Ureter (मूत्रवाहिनी)

गुर्दे से मूत्राशय तक पेशाब ले जाने वाली नली।

UPJ

Ureteropelvic junction — गुर्दे और ureter का मिलन बिंदु; रुकावट की जगह।

Renal pelvis

कीप-आकार की थैली जहाँ पेशाब ureter में जाने से पहले इकट्ठा होता है।

Ureteral stent

एक नरम अंदरूनी नली ("double-J") जो ठीक होने तक जोड़ को खुला रखती है।

Crossing vessel

एक blood vessel जो जंक्शन पर दबाव डालकर रुकावट पैदा करती है।

Hydronephrosis

रुकावट के कारण पेशाब वापस जाने से गुर्दे में सूजन।

Robotic / laparoscopic

छोटे छिद्रों से होने वाली keyhole सर्जरी।

क्या इसमें दर्द होगा? सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में होती है, इसलिए उस दौरान कुछ भी महसूस नहीं होगा। बाद में छोटे चीरों पर हल्का दर्द और keyhole सर्जरी में उपयोग की गई गैस से कंधे या पेट में असुविधा हो सकती है। अंदर का stent पेशाब करते समय तीव्र इच्छा या हल्की बाजू-दर्द दे सकता है। अधिकतर लोग 1-2 रात अस्पताल में रहते हैं; सर्जरी आमतौर पर 2-3 घंटे लेती है।

तैयारी कैसे करें (सर्जरी से पहले)

- सर्जरी **जनरल एनेस्थीसिया** में होती है — सभी निर्देशों का पालन करें (उपवास और कौन सी दवाएँ रोकनी हैं, जैसे blood thinners)।
- संक्रमण जाँचने के लिए **urine test** होती है — संक्रमण होने पर पहले उसका इलाज ज़रूरी है।
- **लगभग 4-6 हफ्तों तक stent अंदर रहेगा** — घर जाने के लिए किसी की व्यवस्था करें।

अपनी टीम को पहले से बताएँ यदि आप:

- **Blood thinner** लेते हों, या अभी urine infection हो
- पहले गुर्दे या पेट की सर्जरी हो चुकी हो

सर्जरी के दौरान क्या होता है

- 1 आप एनेस्थीसिया में सो जाते हैं और antibiotics दी जाती हैं।
- 2 सर्जन कुछ छोटे keyhole चीरे (या एक खुला चीरा) लगाकर बाधित जंक्शन तक पहुँचते हैं।
- 3 संकरे हिस्से को हटाकर renal pelvis को नया आकार दिया जाता है।
- 4 स्वस्थ ureter को stent के ऊपर चौड़े कीप-आकार में pelvis से सिला जाता है; एक छोटा drain छोड़कर चीरे बंद किए जाते हैं।

बाद में

- आमतौर पर **1-2 दिन** में घर जा सकते हैं।
- **stent लगभग 4-6 हफ्ते अंदर रहता है**, फिर clinic में quick cystoscopy से निकाला जाता है।
- Stent के कारण तीव्र पेशाब इच्छा, हल्की बाजू-दर्द या गुलाबी पेशाब — ये **सामान्य** हैं।
- कुछ हफ्तों तक **भारी सामान उठाने और ज़ोर लगाने से बचें**, और खूब पानी पिएँ।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना
- तेज़ या बढ़ता हुआ बाजू या पेट का दर्द
- अधिक रक्तस्राव, या पेशाब में खून के थक्के
- पेशाब न आना, या लगातार जी मिचलाना या उल्टी
- चीरे की जगह पर बढ़ती लालिमा, दर्द या रिसाव

याद रखने योग्य तीन बातें

1. पाइलोप्लास्टी गुर्दे की नाली की रुकावट हटाकर चौड़ा रास्ता बनाती है — यह सबसे टिकाऊ उपाय है, आमतौर पर keyhole चीरों से।
2. तैयारी: उपवास और दवा के निर्देश मानें, पहले किसी संक्रमण का इलाज करें, 4-6 हफ्तों के stent के लिए तैयार रहें, और घर जाने की व्यवस्था करें।
3. Stent निकलने तक तीव्र पेशाब इच्छा या हल्की बाजू-दर्द सामान्य है। बुखार, तेज़ दर्द, अधिक रक्तस्राव, या पेशाब न आने पर तुरंत संपर्क करें।